Estilo UERJ

Simulado 13 Caderno

Prova inédita no formato da UERJ: quatro alternativas, casos longos e a armadilha da banca em cada questão.

50 questões

17 de outubro de 2026

ANTES DE COMEÇAR

Instruções

- São 50 questões de Clínica Médica, com quatro alternativas cada (A a D) e uma única correta.
- Tempo sugerido: 2 horas e 30 minutos, sem consulta, de uma vez só.
- Marque as respostas na folha de respostas da última página, e só depois abra a resolução.
- Nas questões de identificar, faça o teste do resto: liste os achados e veja se a hipótese explica todos. Antes de pedir exame ou tratamento, pergunte qual é o degrau mais simples que resolve e o que o paciente já usa.
- Na correção, anote em qual arma da banca você caiu. É isso que vai para o diagnóstico, não o total.

1 Homem de 63 anos procura a emergência por dor lombar surda há 4 meses, perda de 6 kg e oligúria há 3 dias. Nega uso de derivados do ergot. Tomografia sem contraste: manto de tecido mole envolvendo a aorta abdominal infrarrenal e as ilíacas comuns, que traciona os ureteres medialmente, com hidronefrose bilateral moderada; sem linfonodomegalias em outras cadeias e sem massa pélvica. Exame físico: PA 150 × 92 mmHg, sem edema pulmonar. Exames: creatinina 5,8 mg/dL (0,9 mg/dL há 1 ano), potássio 6,1 mEq/L, pH 7,29, bicarbonato 17 mEq/L, VHS 76 mm/h, IgG4 sérica 98 mg/dL (VR até 135). ECG sem alterações. A conduta imediata e o tratamento da doença de base são, respectivamente:

A) Derivação urinária bilateral / glicocorticoide

B) Hemodiálise de urgência / rituximabe

C) Glicocorticoide isolado / ureterólise se falhar

D) Ureterólise cirúrgica / tamoxifeno

---

2 Em paciente com DPOC internado por exacerbação, o programa de reabilitação pulmonar estruturado (exercício supervisionado) traz maior benefício em readmissões e mortalidade quando iniciado:

A) Após 3 meses de estabilidade

B) Até 4 semanas após a alta

C) Ainda durante a internação

D) Apenas se VEF1 abaixo de 50%

---

3 Gestante de 31 anos, primigesta, com 32 semanas, procura a emergência por febre de 39,1 °C há 4 dias, mialgia, odinofagia e dor em hipocôndrio direito. Nega prurido, cefaleia e escotomas. Pré-natal sem intercorrências; usa apenas sulfato ferroso e nega paracetamol. Sem lesões orais ou genitais ao exame. PA 112×68 mmHg, FC 112 bpm, sem edema, sem asterixe. Exames: AST 4.850 U/L, ALT 3.920 U/L, bilirrubina total 1,1 mg/dL, leucócitos 2.300/mm³, plaquetas 96.000/mm³, INR 1,6, glicemia 88 mg/dL, creatinina 0,7 mg/dL, haptoglobina normal, esfregaço sem esquistócitos, proteinúria negativa. Anti-HAV IgM, HBsAg, anti-HBc IgM e anti-HCV não reagentes. Ultrassonografia: fígado de tamanho normal, sem esteatose, vias biliares normais; feto com vitalidade preservada. A etiologia mais provável da hepatite é:

A) Hepatite por herpes simples

B) Esteatose hepática aguda da gestação

C) Síndrome HELLP

D) Hepatite aguda pelo vírus E

---

4 Mulher de 52 anos, sem cardiopatia, com plaquetas de 18.000/mm³ por leucemia em quimioterapia, recebe uma dose de plaquetas por aférese de doadora multípara antes de passagem de cateter. Uma hora após o fim da infusão, apresenta dispneia intensa, SpO2 de 82% em ar ambiente, temperatura de 38,3 °C, PA 86 × 52 mmHg, FC 124 bpm e estertores difusos. Radiografia de tórax: infiltrado alveolar bilateral novo. Ecocardiograma à beira do leito: FE de 62%, veia cava inferior de 1,2 cm com colapso inspiratório acima de 50%. BNP 70 pg/mL. Balanço hídrico das últimas 24 horas: negativo em 300 mL. A conduta no receptor e a medida em relação à doadora são, respectivamente:

A) Suporte sem diurético / anticorpos anti-HLA e anti-HNA na doadora

B) Suporte sem diurético / nenhuma medida com a doadora

C) Furosemida intravenosa / anticorpos anti-HLA e anti-HNA na doadora

D) Furosemida intravenosa / nenhuma medida com a doadora

---

5 Mulher de 40 anos, hipertensa em uso de losartana (suspensa na internação), foi internada no 5º dia de dengue por dor abdominal intensa e hematócrito de 48%, e recebeu hidratação venosa de cerca de 3 L/dia desde então, mantida por prescrição. Hoje, no 8º dia, está afebril há 36 horas e passou a ter dispneia, ortopneia e tosse seca. Exame: PA 162 × 96 mmHg, FC 90 bpm, FR 28 irpm, SpO2 91% em ar ambiente, estertores crepitantes bibasais, turgência jugular, edema de membros inferiores. Exames: hematócrito de 33%, plaquetas de 58.000/mm³ (eram 22.000/mm³ há 48 horas), albumina 3,2 g/dL, troponina normal, BNP 620 pg/mL. Radiografia: congestão hilar bilateral e pequenos derrames. O diagnóstico mais provável é:

A) Pneumonia hospitalar

B) Miocardite por dengue

C) Extravasamento plasmático com SDRA

D) Hipervolemia da fase de recuperação

---

6 Homem de 34 anos, sem comorbidades, é atendido por síndrome gripal com febre de 39,6 °C há 2 dias. Nunca teve síncope, palpitações, respiração agônica noturna ou crises convulsivas; não há morte súbita ou síncope em parentes de primeiro grau antes dos 45 anos. ECG na admissão, febril: supradesnivelamento do ST de 3 mm em V1 e V2, com morfologia em 'cúpula' e onda T negativa, QRS de 100 ms e QTc de 420 ms. O ECG admissional da empresa, de 1 ano atrás, era normal. Após dipirona e resfriamento, o ECG repetido com 37,0 °C, 12 horas depois, é normal. Ecocardiograma normal; potássio 4,1 mEq/L. Ele vai receber alta. A conduta mais adequada é:

A) Estudo eletrofisiológico para estratificação

B) Quinidina oral contínua

C) Antitérmico precoce e lista de drogas a evitar

D) Implante de cardioversor-desfibrilador

---

7 Homem de 34 anos procura atendimento por cefaleia frontal progressiva há 8 meses e por esbarrar em objetos dos dois lados. Refere queda da libido e ganho de 6 kg. Nega galactorreia. Na anamnese dirigida, conta que há 6 meses acorda três vezes por noite para urinar e bebe cerca de 5 litros de água por dia, com urina clara. Exame: hemianopsia bitemporal, PA 118 × 74 mmHg. Exames: sódio 145 mEq/L, glicemia 92 mg/dL, osmolalidade urinária 140 mOsm/kg, prolactina 54 ng/mL (referência até 15), testosterona total 140 ng/dL com LH baixo, T4 livre baixo com TSH normal, IGF-1 baixo. Ressonância: lesão selar e suprasselar de 3,2 cm, com componente cístico hiperintenso em T1 e componente sólido; a tomografia mostra calcificações periféricas. O diagnóstico mais provável é:

A) Macroadenoma não funcionante

B) Craniofaringioma

C) Macroprolactinoma

D) Hipofisite linfocítica

---

8 Homem de 44 anos, com nefropatia membranosa anti-PLA2R positiva diagnosticada há dois meses (proteinúria de 9 g/24 h, albumina 1,7 g/dL), em uso de losartana e furosemida, aguardando início de rituximabe. Há 12 horas com dor lombar esquerda contínua e urina avermelhada. Afebril, PA 136/84 mmHg, FC 88 bpm, ritmo regular, punho-percussão lombar dolorosa à esquerda; na bolsa escrotal, veias dilatadas e tortuosas à esquerda, que não existiam antes e não esvaziam com o decúbito. ECG em ritmo sinusal. Exames: creatinina 1,9 mg/dL (era 1,0 mg/dL), LDH 610 U/L (até 250), hematúria macroscópica, sem leucocitúria nem nitrito. Ultrassonografia sem hidronefrose e sem cálculos. O diagnóstico mais provável é:

A) Cólica nefrética por cálculo ureteral

B) Trombose da veia renal esquerda

C) Infarto renal por embolia arterial

D) Pielonefrite aguda

---

9 Homem de 45 anos, pedreiro, com lombociatalgia à esquerda há 3 semanas, tratado com diclofenaco e tramadol 50 mg de 6 em 6 horas, volta ao pronto-socorro porque há 18 horas 'não consegue urinar direito' e precisa fazer força. Refere que a dor piorou e agora irradia para as duas pernas, e uma 'dormência estranha' ao se limpar após evacuar. PA 138/84 mmHg, afebril. Exame: Lasègue positivo a 40 graus bilateralmente, força grau 5 nos membros inferiores, aquileu diminuído à esquerda, hipoestesia tátil e dolorosa na região perineal e na face medial das nádegas, tônus anal diminuído ao toque. Ultrassonografia vesical: resíduo pós-miccional de 620 mL. O residente atribui a retenção ao opioide e propõe sondagem de alívio. Além do cateterismo vesical, o exame mais adequado agora é:

A) Estudo urodinâmico após suspender tramadol

B) Eletroneuromiografia dos membros inferiores

C) RM de coluna lombossacra de urgência

D) Radiografia dinâmica da coluna lombar

---

10 Homem de 28 anos, com aftas orais recorrentes desde a adolescência, duas úlceras escrotais já cicatrizadas, pseudofoliculite e uveíte posterior tratada há 1 ano, apresenta edema doloroso da perna esquerda há 4 dias. Doppler: trombose venosa femoral e poplítea esquerda. Teve tromboflebite superficial no braço direito há 6 meses. Sem dispneia nem hemoptise; angiotomografia de tórax sem trombos e sem aneurismas de artérias pulmonares. Usa colchicina. Exames: plaquetas 290.000/mm³, função renal normal, anticoagulante lúpico e anticardiolipinas negativos. A conduta mais adequada para a trombose é:

A) Anticoagulação isolada por 3 meses

B) Glicocorticoide e azatioprina

C) Filtro de veia cava inferior

D) Trombólise dirigida por cateter

---

11 Homem de 61 anos, com cirrose por doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica, nunca descompensou. Tem fibrilação atrial e usa um anticoagulante oral que exige coleta mensal de sangue para ajuste da dose. Exame sem ascite, icterícia ou encefalopatia. Exames: bilirrubina 1,3 mg/dL, albumina 3,9 g/dL, creatinina 1,0 mg/dL, sódio 136 mEq/L, INR 2,6, plaquetas 118.000/mm³. O MELD calculado é 18. A interpretação correta desse MELD é:

A) Reflete descompensação iminente

B) Está superestimado pelo anticoagulante

C) Contraindica manter a anticoagulação

D) Indica avaliação para transplante

---

12 Homem de 63 anos, tabagista de 55 maços-ano, hipertenso em uso de hidroclorotiazida 25 mg/dia há 4 anos, procura a emergência por fraqueza progressiva nas pernas há 3 semanas e edema. PA 172/100 mmHg, FC 92 bpm. IMC 23 kg/m², perdeu 6 kg em 2 meses; sem estrias, face arredondada ou giba. Exames: potássio 2,1 mEq/L, bicarbonato 36 mEq/L, sódio 145 mEq/L, creatinina 0,9 mg/dL, glicemia 268 mg/dL (era 92 mg/dL há 6 meses). Radiografia de tórax: alargamento hilar direito. A causa mais provável da hipocalemia é:

A) Secreção ectópica de ACTH

B) Efeito da hidroclorotiazida

C) Hiperaldosteronismo primário

D) Hipertensão renovascular

---

13 Mulher de 27 anos, sem comorbidades, teve trombose venosa profunda iliofemoral esquerda há 14 meses, em uso de anticoncepcional oral combinado. Foi anticoagulada com rivaroxabana por 6 meses e o anticoncepcional foi suspenso definitivamente. Pesquisa de trombofilia hereditária e de anticorpos antifosfolípide, feita fora da anticoagulação, foi negativa. Há 5 dias, 8 meses após suspender a rivaroxabana, nova trombose proximal na mesma perna esquerda, que se estende desde a veia ilíaca comum, sem cirurgia, viagem ou imobilização. Hemograma, função renal e hepática e exame ginecológico normais. Já reiniciou anticoagulação. Além de manter a anticoagulação, o próximo exame mais adequado é:

A) Pesquisa da mutação JAK2 V617F

B) Venografia por TC do abdome e da pelve

C) Marcadores tumorais séricos

D) Repetir pesquisa de trombofilia hereditária

---

14 Homem de 50 anos, apicultor amador, foi atacado por um enxame ao abrir uma caixa sem proteção há 2 horas e contou cerca de 300 picadas na cabeça, tronco e braços. Chegou com urticária generalizada, sibilância e PA 76 × 40 mmHg; recebeu adrenalina 0,5 mg IM, cristaloide, anti-histamínico e corticoide, com resposta completa. Os ferrões foram retirados por raspagem com lâmina. Agora: PA 128 × 80 mmHg, FC 92 bpm, SpO2 98%, sem sibilos, sem edema de glote, urina clara. Refere dor difusa e mialgia leve. Não tem doença prévia nem usa medicamentos. A família pede alta após as 6 horas de observação habituais da anafilaxia. O próximo passo mais adequado é:

A) Triptase sérica e alta após 6 horas

B) Internação com CK e creatinina seriadas

C) IgE específica para veneno de abelha

D) Alta com adrenalina autoinjetável

---

15 Homem de 54 anos, nascido no norte de Minas Gerais, onde viveu até os 20 anos, procura atendimento por palpitações e dispneia aos médios esforços há 6 meses. Há 15 anos tem dificuldade para engolir sólidos e líquidos, com regurgitação noturna, e perdeu 7 kg; esofagograma antigo mostrou esôfago dilatado com afilamento distal em 'bico de pássaro'. Nega etilismo e angina. Um exame de sangue de 3 anos atrás registrou 'eosinófilos 900/mm³', atribuídos a verminose e tratados com albendazol; o hemograma atual tem 280 eosinófilos/mm³. PA 112×70 mmHg, FC 58 bpm, irregular por extrassístoles; bulhas normofonéticas, sem sopros; sem estase jugular. ECG: bloqueio de ramo direito, bloqueio divisional anterossuperior esquerdo e extrassístoles ventriculares polimórficas. A alteração mais esperada no ecocardiograma é:

A) Hipertrofia septal assimétrica

B) Obliteração apical por fibrose endocárdica

C) Dilatação da raiz da aorta

D) Aneurisma apical do ventrículo esquerdo

---

16 Homem de 46 anos, em hemodiálise por 9 anos por glomerulonefrite crônica, recebeu transplante renal de doador falecido há 14 meses, com boa função do enxerto (creatinina 1,2 mg/dL). Antes do transplante usava calcitriol, cinacalcete e sevelâmer, com PTH entre 1.100 e 1.500 pg/mL; os três foram suspensos no transplante. Usa tacrolimo, micofenolato e prednisona 5 mg/dia. Na revisão, assintomático: cálcio total 11,4 mg/dL (albumina 4,1 g/dL), fósforo 2,0 mg/dL, PTH 620 pg/mL, 25-hidroxivitamina D 32 ng/mL, fosfatase alcalina levemente elevada. O cálcio já estava em 10,9 mg/dL no terceiro mês e não normalizou desde então. Ultrassonografia cervical: quatro paratireoides aumentadas. A causa da hipercalcemia é:

A) Hiperparatireoidismo terciário persistente

B) Excesso de calcitriol exógeno

C) Adenoma de paratireoide primário

D) Hiperparatireoidismo secundário em regressão

---

17 Mulher de 32 anos, primigesta com 29 semanas, com nefropatia por IgA diagnosticada por biópsia há três anos, creatinina pré-gestacional de 1,1 mg/dL e proteinúria de 0,9 g/24 h; trocou a losartana por nifedipino antes de engravidar e usa AAS 150 mg/dia desde a 12ª semana. Na consulta de rotina: PA 146/94 mmHg (era 124/78 mmHg com 24 semanas), sem cefaleia, sem dor epigástrica, edema discreto. Exames: creatinina 1,2 mg/dL, relação proteína/creatinina urinária de 2,4 g/g (era 1,0 g/g no primeiro trimestre), sedimento com 8 hemácias por campo (semelhante aos anteriores), hemoglobina 11,2 g/dL, plaquetas 210.000/mm³, AST 22 U/L, LDH 190 U/L. Ultrassonografia obstétrica com crescimento fetal no percentil 40. Para separar pré-eclâmpsia sobreposta de atividade da doença renal, o exame mais útil neste momento é:

A) Relação sFlt-1/PlGF sérica

B) Biópsia renal percutânea

C) Proteinúria de 24 horas

D) Ácido úrico sérico

---

18 Homem de 66 anos, com adenocarcinoma de pulmão metastático para ossos e ECOG 1 até o mês passado, procura atendimento por paraplegia completa (força grau 0 nos membros inferiores), nível sensitivo em T8 e retenção urinária, instalados há 4 dias, depois de 3 semanas de dorsalgia. Ressonância de toda a coluna: metástase em T8 com compressão epidural, colapso de 30% do corpo vertebral sem retropulsão e coluna considerada estável; demais níveis sem compressão. Expectativa de vida estimada maior que 6 meses. Já recebeu dexametasona. A conduta mais adequada para a compressão é:

A) Descompressão cirúrgica seguida de radioterapia

B) Vertebroplastia com cimento

C) Radioterapia

D) Dexametasona e reabilitação, sem radioterapia

---

19 Homem de 58 anos, com hemorragia intraparenquimatosa hipertensiva e herniação, cumpre todos os pré-requisitos e é submetido ao protocolo de morte encefálica: primeiro exame clínico concluído às 8h; teste de apneia concluído às 8h40, com PaCO2 final de 68 mmHg e nenhum movimento respiratório; segundo exame clínico, por outro médico capacitado, concluído às 10h; Doppler transcraniano com padrão de parada circulatória encefálica concluído às 13h. A família, informada de cada etapa, recusa a doação; o suporte é retirado e a assistolia ocorre às 16h. Pela Resolução CFM nº 2.173/2017, a hora a ser registrada como a da morte na declaração de óbito é:

A) 8h40

B) 10h

C) 13h

D) 16h

---

20 Homem de 34 anos teve uretrite por Chlamydia trachomatis há 9 meses, tratada com doxiciclina por 7 dias junto com a parceira, com teste de controle negativo. Duas semanas depois surgiu artrite de joelho direito e tornozelo esquerdo, com entesite no calcâneo. Usou naproxeno em dose plena e depois indometacina em dose plena, e recebeu duas infiltrações de corticoide no joelho, com melhora parcial e recidiva. Hoje mantém sinovite de joelho e tornozelo, sem dor lombar inflamatória, uveíte ou lesões de pele. HLA-B27 positivo, VHS 42 mm/h, PCR 22 mg/L, radiografias sem erosões; sorologias para HIV, hepatite B e hepatite C negativas. A conduta mais adequada é:

A) Doxiciclina por 3 meses

B) Sulfassalazina 2 a 3 g/dia

C) Prednisona 1 mg/kg/dia

D) Anti-TNF imediatamente

---

21 Homem de 68 anos é internado por febre, exantema maculopapular pruriginoso difuso e edema facial, iniciados 9 dias após amoxicilina para sinusite. Há 2 meses já referia sudorese noturna e perda de 6 kg. Exame: linfonodomegalias cervicais, axilares e inguinais de 2 a 3 cm, hepatoesplenomegalia e pequeno derrame pleural bilateral. Exames: Hb 9,4 g/dL, Coombs direto positivo, eosinófilos 1.600/mm³, plaquetas 140.000/mm³, LDH 620 U/L, gamaglobulina policlonal de 3,1 g/dL, AST, ALT e creatinina normais. Suspensa a amoxicilina e iniciada prednisona, o exantema melhorou em 1 semana, mas os linfonodos persistiam após 4 semanas. Biópsia excisional de linfonodo axilar: apagamento da arquitetura, proliferação de vênulas de endotélio alto, expansão da rede de células dendríticas foliculares, células T atípicas CD4+, PD-1+, CD10+ e CXCL13+, e imunoblastos B esparsos EBV positivos. O diagnóstico mais provável é:

A) DRESS pela amoxicilina

B) Doença de Castleman multicêntrica

C) Linfoma T angioimunoblástico

D) Linfoma de Hodgkin clássico

---

22 Homem de 52 anos, sem valvopatia conhecida, está no 8º dia de oxacilina por endocardite de valva aórtica nativa por Staphylococcus aureus sensível à oxacilina. As hemoculturas negativaram no 3º dia e ele ficou afebril, mas há 2 dias voltou a ter febre de 38,3 °C. Não há flebite, o cateter periférico foi trocado, urina e radiografia de tórax normais; sem exantema e sem eosinofilia. ECG da admissão: ritmo sinusal, PR de 160 ms; ECG de hoje: ritmo sinusal, PR de 280 ms, sem outras alterações. PA 122 x 64 mmHg, sem sinais de insuficiência cardíaca. O ecocardiograma transtorácico mostra a mesma vegetação de 8 mm e insuficiência aórtica leve. A complicação mais provável e a conduta, respectivamente, são:

A) Abscesso perivalvar / cirurgia urgente

B) Abscesso perivalvar / ampliar o antibiótico

C) Febre por betalactâmico / trocar por cefazolina

D) Miocardite séptica / manter o esquema

---

23 Mulher de 34 anos com hipertensão arterial pulmonar idiopática, classe funcional III, caminha 330 m no teste de 6 minutos; NT-proBNP 900 pg/mL. Cateterismo direito: pressão média da artéria pulmonar (PAPm) 52 mmHg, pressão de oclusão 9 mmHg, resistência vascular pulmonar 12 unidades Wood, débito cardíaco 3,6 L/min. No teste de vasorreatividade com óxido nítrico inalado, a PAPm cai para 41 mmHg, com débito cardíaco de 3,8 L/min. O resultado do teste e o tratamento inicial mais adequado são, respectivamente:

A) Positivo / nifedipino em dose alta

B) Positivo / ambrisentana e tadalafila

C) Negativo / nifedipino em dose alta

D) Negativo / ambrisentana e tadalafila

---

24 Mulher de 68 anos, tabagista ativa de 50 anos-maço, hipertensa e com diabetes tipo 2 há 15 anos com retinopatia, refere há 6 meses dor abdominal periumbilical em cólica que começa 20 a 30 minutos após as refeições e dura 1 a 2 horas. Passou a comer pouco por medo da dor e perdeu 11 kg. Endoscopia e colonoscopia recentes normais; TC de abdome sem contraste sem massas. Cintilografia de esvaziamento gástrico com retenção de 18% em 4 horas (normal até 10%), e o quadro foi atribuído a gastroparesia diabética. Exame: abdome flácido e indolor, com sopro epigástrico; pulsos pediosos diminuídos. Lipase e enzimas hepáticas normais. O diagnóstico mais provável é:

A) Câncer de pâncreas oculto

B) Gastroparesia diabética

C) Isquemia mesentérica crônica

D) Pancreatite crônica

---

25 Homem de 58 anos, sem doenças prévias, procura atendimento por palpitações e dispneia progressiva há 4 meses. ECG: fibrilação atrial com resposta ventricular de 140 bpm. Ecocardiograma: VE com diâmetro diastólico de 61 mm, FE 28%, hipocinesia difusa, átrio esquerdo de 46 mm. Cineangiocoronariografia sem lesões; ressonância sem realce tardio; TSH normal, sem etilismo. Está há 5 semanas em uso regular de apixabana, carvedilol em dose máxima tolerada, sacubitril-valsartana, espironolactona e dapagliflozina; a FC em repouso caiu para 112 bpm, mas no Holter a média de 24 horas é 118 bpm. Sem sinais de congestão hoje. O cardiologista do convênio sugere implantar logo um cardiodesfibrilador 'porque a FE está abaixo de 35%'. A conduta mais adequada neste momento é:

A) Associar digoxina e manter o controle de frequência

B) Cardioversão elétrica e reavaliação da FE em 3 meses

C) Ablação do nó atrioventricular com marca-passo

D) Implante de cardiodesfibrilador para prevenção primária

---

26 Mulher de 29 anos procura atendimento por aumento bilateral das parótidas há 3 semanas, com febre baixa, olhos vermelhos e fotofobia há 10 dias e, desde ontem, dificuldade para fechar o olho esquerdo e desvio da boca para a direita. Mora com um sobrinho de 5 anos que teve caxumba há 1 mês, e não tem registro de vacinação. Exame físico: Tax 37,8 °C, parótidas aumentadas, firmes e pouco dolorosas, sem saída de pus pelo ducto; paralisia facial periférica à esquerda; injeção ciliar bilateral com precipitados ceráticos em gordura de carneiro. Exames: amilase 210 U/L, cálcio 10,9 mg/dL, linfócitos 900/mm³. Radiografia de tórax com alargamento hilar bilateral e simétrico. O diagnóstico mais provável é:

A) Sarcoidose com febre uveoparotídea

B) Caxumba com neurite facial

C) Síndrome de Sjögren primária

D) Linfoma não Hodgkin

---

27 Mulher de 52 anos, com última menstruação há 16 meses, procura atendimento por fogachos intensos (cerca de 12 por dia), despertares noturnos e prejuízo no trabalho, sem melhora com medidas comportamentais. Tem útero e ovários. Tem enxaqueca sem aura, hipertensão controlada com losartana, IMC 33 kg/m² e triglicerídeos de 410 mg/dL; não tem antecedente de trombose, câncer de mama nem doença coronariana. Mamografia BI-RADS 1 há 4 meses e risco cardiovascular em 10 anos estimado em 6%. Ela deseja tratamento hormonal. Quanto à via do estrogênio e à associação com progestagênio, a conduta mais adequada é, respectivamente:

A) Oral / com progestagênio

B) Transdérmica / sem progestagênio

C) Transdérmica / com progestagênio

D) Oral / sem progestagênio

---

28 Homem de 66 anos, em hemodiálise há quatro anos por doença renal do diabetes, anúrico, com sessões às segundas, quartas e sextas-feiras por fístula arteriovenosa e ganho de peso interdialítico habitual de 1,5 kg. Na terça-feira pela manhã faz tomografia de abdome com 100 mL de contraste iodado de baixa osmolalidade, para investigar dor lombar. Depois do exame está assintomático: PA 138/82 mmHg, FC 78 bpm, sem dispneia, SpO2 de 97% em ar ambiente, sem estertores; potássio de 5,1 mEq/L na véspera. Em relação ao contraste, a conduta mais adequada é:

A) Hidratação venosa com salina isotônica

B) Manter a sessão de quarta, sem extras

C) Hemodiálise adicional logo após o exame

D) N-acetilcisteína oral por 48 horas

---

29 Homem de 70 anos está no 1º dia de pós-operatório de correção endovascular de aneurisma toracoabdominal, com cobertura extensa da aorta descendente; a PAM chegou a 55 mmHg por 20 minutos no intraoperatório. Ao despertar, refere que não mexe as pernas e não sente a sonda vesical. Exame: paraplegia flácida, patelares e aquileus abolidos, nível sensitivo para dor e temperatura em T10, com sensibilidade vibratória e posição segmentar preservadas nos pés; membros superiores normais. Sem febre e sem dor dorsal; o cateter peridural foi retirado há 10 horas com coagulograma normal. RM de coluna torácica sem coleção e sem compressão; difusão inconclusiva pelo artefato da prótese. A causa mais provável é:

A) Hematoma epidural pelo cateter peridural

B) Infarto da artéria espinal anterior

C) Mielite transversa aguda

D) Síndrome de Guillain-Barré

---

30 Mulher de 63 anos, com dispneia aos pequenos esforços e edema de membros inferiores há 5 meses, macroglossia e púrpura periorbitária. Ecocardiograma: hipertrofia concêntrica de 15 mm, FE de 50%, strain longitudinal com preservação apical. ECG com baixa voltagem. NT-proBNP 6.200 pg/mL, troponina T 0,09 ng/mL, cadeias leves livres lambda 380 mg/L e kappa 11 mg/L. Aspirado de gordura abdominal com vermelho Congo positivo; tipagem por espectrometria de massa: cadeia leve lambda. Medula com 8% de plasmócitos clonais. Creatinina 1,1 mg/dL. PA 96 × 62 mmHg, FC 88 bpm. O tratamento inicial mais adequado é:

A) Tafamidis 61 mg ao dia

B) Melfalano em alta dose com autotransplante

C) Transplante cardíaco isolado

D) Daratumumabe, ciclofosfamida, bortezomibe e dexametasona

---

31 Mulher de 27 anos, com DIU de cobre há 2 anos, procura a UBS com dor em baixo ventre há 4 dias, corrimento amarelado e febre de 37,9 °C. Tem parceiro fixo e um parceiro eventual recente. Exame: PA 118 × 74 mmHg, FC 92 bpm, abdome doloroso em hipogástrio, sem descompressão dolorosa; ao toque, dor à mobilização do colo e anexos dolorosos bilateralmente, sem massa palpável; fios do DIU visíveis. β-hCG negativo. Ultrassonografia transvaginal: DIU bem posicionado, sem abscesso tubo-ovariano e sem coleção. Tolera dieta oral e não tem vômitos. A conduta mais adequada é:

A) Ceftriaxona, doxiciclina e metronidazol, mantendo o DIU

B) Internação e antibiótico intravenoso

C) Ceftriaxona, doxiciclina e metronidazol, retirando o DIU

D) Retirada do DIU e reavaliação em 72 horas

---

32 Homem de 58 anos tem dor em fossa ilíaca esquerda há 4 dias e febre de 38,4 °C. PA 128×78 mmHg, FC 98 bpm. Abdome com dor e defesa localizadas na fossa ilíaca esquerda, sem sinais de peritonite difusa. Leucócitos 16.800/mm³, PCR 190 mg/L. TC com contraste: espessamento do sigmoide com divertículos e coleção pélvica de 6 cm, com parede realçada, sem gás livre fora da coleção e sem líquido livre difuso. Nunca fez colonoscopia. A classificação de Hinchey e a conduta inicial são, respectivamente:

A) Hinchey II / antibiótico e drenagem percutânea

B) Hinchey Ib / antibiótico isolado

C) Hinchey III / sigmoidectomia de urgência

D) Hinchey II / antibiótico isolado

---

33 Homem de 52 anos, fototipo II, tem no dorso uma lesão pigmentada de 9 mm, assimétrica, de bordas irregulares, com três tons de castanho e preto, que mudou de tamanho nos últimos 6 meses. A dermatoscopia mostra rede atípica e véu azul-esbranquiçado. Não há linfonodos palpáveis. A lesão é inteiramente acessível, e o fechamento primário após retirada é simples. O próximo passo mais adequado é:

A) Biópsia por shaving superficial

B) PET-CT antes da biópsia

C) Biópsia excisional com margem de 1 a 3 mm

D) Ampliação com margem de 2 cm

---

34 Mulher de 27 anos tem doença de Still do adulto há 2 anos, controlada com tocilizumabe endovenoso a cada 4 semanas e prednisona 5 mg/dia; a última infusão foi há 12 dias. Há 3 semanas teve faringite e há 10 dias sente astenia intensa e dor abdominal, sem febre aferida e sem exantema. Exame físico: Tax 37,1 °C, FC 110 bpm, PA 100 × 62 mmHg, baço palpável a 3 cm do rebordo. Exames de 2 meses atrás e de hoje, respectivamente: leucócitos 7.800 e 3.100/mm³; plaquetas 260.000 e 96.000/mm³; ferritina 310 e 14.600 ng/mL; AST 28 e 240 U/L; triglicerídeos 140 e 420 mg/dL; fibrinogênio 290 e 120 mg/dL; PCR 0,3 e 0,8 mg/dL. A explicação mais provável para a PCR praticamente normal neste momento é:

A) Doença de Still em remissão

B) Consumo da PCR pelos macrófagos ativados

C) Bloqueio da síntese hepática dependente de IL-6

D) Insuficiência hepática pela ativação macrofágica

---

35 Mulher de 33 anos procura atendimento por dispneia progressiva há 3 meses, hoje aos pequenos esforços, com ortopneia. Teve síndrome gripal há 6 semanas e acredita que 'o vírus atacou o coração'. Aos 14 anos tratou um tumor ósseo maligno do fêmur com quimioterapia antes e depois da cirurgia, e está em remissão desde então. Teve um parto há 4 anos, sem intercorrências. Bebe duas doses por semana; nega drogas. PA 104×68 mmHg, FC 104 bpm, B3, estertores em bases, edema de tornozelos. ECG: taquicardia sinusal, sem áreas inativas. Ecocardiograma: VE com diâmetro diastólico de 63 mm, FE 30%, hipocinesia difusa. Troponina discretamente elevada e estável; sorologia para Chagas negativa; TSH normal. Ressonância cardíaca: dilatação biventricular, sem edema miocárdico em T2 e sem realce tardio. Coronárias normais na angiotomografia. A etiologia mais provável da cardiomiopatia é:

A) Cardiomiopatia periparto

B) Cardiotoxicidade tardia por antraciclina

C) Cardiomiopatia alcoólica

D) Miocardite viral aguda

---

36 Mulher de 58 anos, destra, com doença renal policística autossômica dominante, TFGe de 17 mL/min/1,73 m² com queda de 4 mL/min por ano, já orientada para hemodiálise e com avaliação para fístula arteriovenosa marcada para o próximo mês. Internada por osteomielite vertebral por Staphylococcus aureus sensível à oxacilina, terá seis semanas de cefazolina intravenosa três vezes ao dia, com alta prevista para terminar o tratamento em casa. As veias dos antebraços estão pérvias à ultrassonografia. Para o tratamento domiciliar, preservando o futuro acesso para diálise, o acesso venoso mais adequado é:

A) Cateter não tunelizado em subclávia

B) PICC no braço direito, dominante

C) Acesso periférico trocado a cada 72 horas

D) Cateter tunelizado fino na jugular

---

37 Na neuropatia autonômica cardiovascular do diabetes, a alteração que costuma surgir mais precocemente, ainda sem sintomas, é:

A) Hipotensão ortostática sintomática

B) Frequência cardíaca fixa em repouso

C) Resposta pressórica reduzida ao handgrip

D) Menor variação da FC na respiração profunda

---

38 Na ausência de linfonodomegalias, organomegalias, citopenias e sintomas, a linfocitose B monoclonal com fenótipo de leucemia linfocítica crônica se distingue da LLC por uma contagem de linfócitos B clonais no sangue periférico abaixo de:

A) 5.000/mm³

B) 10.000/mm³

C) 4.000/mm³

D) 15.000/mm³

---

39 Homem de 67 anos, diabético há 15 anos (HbA1c 8,9%), acorda com visão dupla horizontal ao olhar para a esquerda. Sem cefaleia e sem dor ocular. O clínico registra 'provável paralisia microvascular do III nervo direito' porque o olho direito não aduz no olhar conjugado para a esquerda. Pupilas isocóricas e fotorreagentes, sem ptose; ao olhar para a esquerda, o olho esquerdo abduz por completo com nistagmo; ao olhar para a direita, os dois olhos se movem normalmente. PA 170/94 mmHg. O achado que, se presente, localiza a lesão no fascículo longitudinal medial e afasta a lesão do III nervo é:

A) Ptose da pálpebra direita

B) Limitação da elevação do olho direito

C) Pupila direita fotorreagente

D) Adução direita na convergência

---

40 Homem de 38 anos, previamente hígido, tem hepatite B aguda há 3 semanas (HBsAg e anti-HBc IgM reagentes, anti-HDV não reagente). Está ictérico, sem confusão mental e sem ascite, em seguimento ambulatorial. Exames de hoje: ALT 2.400 U/L, bilirrubina total 6 mg/dL, RNI 1,1, albumina 3,9 g/dL. Nesse paciente, o tratamento antiviral (tenofovir ou entecavir) passará a estar indicado se surgir:

A) HBeAg reagente com HBV-DNA alto

B) ALT acima de 1.000 U/L por 4 semanas

C) Icterícia que dure mais de 2 semanas

D) RNI acima de 1,5 ou encefalopatia

---

41 Mulher de 56 anos tratou há 5 anos carcinoma ductal invasivo de mama com receptor de estrogênio positivo e HER2 1+, seguido de 5 anos de hormonioterapia. Agora apresenta metástases hepáticas múltiplas, sem crise visceral, com bilirrubina e enzimas normais. Biópsia hepática: carcinoma de origem mamária, receptor de estrogênio positivo em 80%, receptor de progesterona negativo e HER2 escore 2+ na imuno-histoquímica. A equipe cogita trastuzumabe, pertuzumabe e taxano por considerar o tumor HER2 positivo. O próximo exame mais adequado é:

A) Painel genômico de 21 genes

B) Pesquisa de mutação de PIK3CA

C) Nova imuno-histoquímica no tumor primário

D) Hibridização in situ para HER2

---

42 Homem de 76 anos, com sequela de AVC e disfagia para líquidos documentada, tem febre há 2 dias, tosse e dispneia, iniciadas após um engasgo durante o almoço. FR 24 irpm, PA 128/76 mmHg, SpO2 91% em ar ambiente, nível de consciência igual ao habitual; ureia 38 mg/dL. Radiografia: consolidação no segmento posterior do lobo inferior direito, sem cavitação, sem nível hidroaéreo e sem derrame. Não recebeu antibiótico nem foi internado nos últimos 90 dias; não é etilista, e a dentição está em bom estado. Internado em enfermaria, o esquema antimicrobiano mais adequado é:

A) Clindamicina isolada

B) Ceftriaxona e metronidazol

C) Ceftriaxona e azitromicina

D) Piperacilina-tazobactam

---

43 Mulher de 36 anos tem lúpus eritematoso sistêmico há 6 anos, com manifestações cutâneas e articulares controladas com hidroxicloroquina. Há 2 meses tem edema de membros inferiores progressivo e urina espumosa, sem hematúria macroscópica, artrite ou exantema. Não usa anti-inflamatórios. PA 128 × 80 mmHg. Exames: albumina 2,1 g/dL, colesterol total 340 mg/dL, proteinúria de 6,2 g/24 h, creatinina 0,8 mg/dL, sedimento com 2 hemácias por campo e sem cilindros celulares, C3 e C4 normais, anti-DNA não reagente, anti-Sm reagente. A biópsia renal foi indicada. A classe histológica mais provável é:

A) II, mesangial

B) III, focal

C) IV, difusa

D) V, membranosa

---

44 Mulher de 34 anos, hipertensa crônica controlada com enalapril e clortalidona, sem lesão de órgão-alvo, quer engravidar nos próximos meses. Para prevenção de pré-eclâmpsia e controle pressórico na gestação, a medida indicada e o anti-hipertensivo adequado são, respectivamente:

A) AAS a partir de 12 semanas / metildopa

B) AAS a partir de 20 semanas / metildopa

C) Heparina profilática / metildopa

D) AAS a partir de 20 semanas / losartana

---

45 Homem de 71 anos procura atendimento por dor e cianose nas pontas dos dedos das mãos e nas orelhas, com piora no frio, há 1 mês, e necrose em duas polpas digitais. Refere episódios de turvação visual e cefaleia. Exame: livedo reticular nas coxas, necrose de duas polpas digitais com pulsos periféricos presentes; fundo de olho com veias tortuosas e dilatadas em salsicha. Exames: Hb 11,1 g/dL, reticulócitos, LDH e bilirrubinas normais, Coombs direto negativo, creatinina 1,0 mg/dL, urina sem hematúria, VHS 110 mm/h, C3 e C4 normais, fator reumatoide negativo, anti-HCV e HBsAg negativos, FAN e ANCA negativos. Eletroforese de proteínas com pico monoclonal de 3,2 g/dL, IgM kappa. Crioprecipitado presente no soro, com criócrito de 9%. A etiologia mais provável das lesões cutâneas é:

A) Crioglobulinemia mista pela hepatite C

B) Crioglobulinemia tipo I por gamopatia IgM

C) Doença das aglutininas frias

D) Embolia de colesterol

---

46 Homem de 74 anos, no 4º dia de pós-operatório de artroplastia de quadril, evolui com distensão abdominal progressiva, pouca dor e eliminação escassa de flatos. A oxicodona foi suspensa no início da distensão. Há 48 horas está em jejum, com sonda nasogástrica e sonda retal, deambulação estimulada e correção de potássio e magnésio, hoje normais; a distensão aumentou. Tem bloqueio atrioventricular de segundo grau Mobitz I conhecido; FC 48 bpm, PA 128×70 mmHg. Abdome timpânico, sem defesa e sem descompressão dolorosa. Lactato e leucócitos normais. TC: dilatação de ceco (12,5 cm), cólon ascendente e transverso, sem ponto de transição mecânico, sem pneumatose e sem pneumoperitônio. A conduta mais adequada para este paciente é:

A) Neostigmina intravenosa com monitorização

B) Manter o suporte por mais 72 horas

C) Colectomia direita de urgência

D) Descompressão colonoscópica

---

47 Mulher de 43 anos foi submetida, há 5 meses, a adrenalectomia direita aberta por carcinoma adrenocortical de 11 cm secretor de cortisol, com Ki-67 de 18%. Iniciou mitotano adjuvante há 3 meses (nível sérico atual de 16 mg/L, alvo de 14 a 20) e usa hidrocortisona 20 mg/dia desde a cirurgia. Há 4 semanas tem astenia intensa, náuseas, anorexia e tontura ao levantar. PA 92 × 58 mmHg deitada e 78 × 50 mmHg em pé. Sódio 131 mEq/L, potássio 4,8 mEq/L, glicemia 74 mg/dL. Cortisol sérico total às 8 horas, 2 horas após a hidrocortisona: 21 µg/dL (referência 5 a 25). TSH 2,1 mUI/L, T4 livre 0,8 ng/dL (referência 0,9 a 1,8). Tomografia sem recidiva. O mecanismo que melhor explica o quadro é:

A) Recidiva tumoral com hipercortisolismo

B) Neurotoxicidade por nível alto de mitotano

C) Hipotireoidismo central causado pelo mitotano

D) Mais CBG e depuração acelerada da hidrocortisona

---

48 Mulher de 74 anos, com fibrilação atrial em uso de rivaroxabana 20 mg uma vez ao dia, tomou a última dose há 60 horas, antes de suspender todos os remédios por gastroenterite com vômitos. É trazida por cefaleia e hemiparesia direita leve iniciadas há 3 horas. PA 168/92 mmHg, Glasgow 15. TC: hematoma lobar parietal esquerdo de 14 mL, sem extensão ventricular. Creatinina 0,9 mg/dL (clearance estimado de 62 mL/min), RNI 1,1, TTPa normal, plaquetas 230.000/mm³; atividade anti-Xa calibrada para rivaroxabana abaixo do limite de detecção. Além do controle pressórico, quanto à reversão da anticoagulação, a conduta mais adequada é:

A) Nenhum agente reversor

B) Andexanet alfa em bolus e infusão

C) Complexo protrombínico 50 UI/kg

D) Plasma fresco congelado 15 mL/kg

---

49 Na bacteremia por Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, tratada com vancomicina em adulto com função renal estável, o parâmetro recomendado para monitorar a dose e o seu alvo, para reduzir a nefrotoxicidade sem perder eficácia, são, respectivamente:

A) Nível de vale / 15 a 20 mg/L

B) Nível de vale / 10 a 15 mg/L

C) AUC de 24 horas / 400 a 600 mg·h/L

D) AUC de 24 horas / 600 a 800 mg·h/L

---

50 Homem de 31 anos, com aids (CD4 45 células/mm³), trata tuberculose pulmonar há 4 semanas com o esquema básico de 4 drogas em dose fixa combinada. Iniciou há 2 semanas tenofovir, lamivudina e dolutegravir 50 mg de 12/12 horas. Foi internado com febre, pancitopenia, hepatoesplenomegalia e lesões papulares na face; antígeno de Histoplasma na urina reagente. Recebeu anfotericina B lipossomal por 2 semanas, com melhora clínica, afebril, sem acometimento do SNC. A equipe planeja passar para a fase de consolidação oral. A conduta mais adequada é:

A) Itraconazol 200 mg de 12/12 h, mantendo os esquemas

B) Fluconazol 800 mg/dia, mantendo os esquemas

C) Itraconazol, trocando rifampicina por rifabutina

D) Voriconazol, mantendo os esquemas

FOLHA DE RESPOSTAS

Simulado 13

Nome: _____ Data: ___/___/_____ Início: ___h___ Fim: ___h___

1	A	B	C	D	2	A	B	C	D	3	A	B	C	D	4	A	B	C	D
5	A	B	C	D	6	A	B	C	D	7	A	B	C	D	8	A	B	C	D
9	A	B	C	D	10	A	B	C	D	11	A	B	C	D	12	A	B	C	D
13	A	B	C	D	14	A	B	C	D	15	A	B	C	D	16	A	B	C	D
17	A	B	C	D	18	A	B	C	D	19	A	B	C	D	20	A	B	C	D
21	A	B	C	D	22	A	B	C	D	23	A	B	C	D	24	A	B	C	D
25	A	B	C	D	26	A	B	C	D	27	A	B	C	D	28	A	B	C	D
29	A	B	C	D	30	A	B	C	D	31	A	B	C	D	32	A	B	C	D
33	A	B	C	D	34	A	B	C	D	35	A	B	C	D	36	A	B	C	D
37	A	B	C	D	38	A	B	C	D	39	A	B	C	D	40	A	B	C	D
41	A	B	C	D	42	A	B	C	D	43	A	B	C	D	44	A	B	C	D
45	A	B	C	D	46	A	B	C	D	47	A	B	C	D	48	A	B	C	D
49	A	B	C	D	50	A	B	C	D										